Stationärer Arztbrief beim akuten Schlaganfall

M. Mühlau, H. Poppert

zuletzt aktualisiert: 23.04.2008, August 2012

Umfang möglichst ≤ 2 Seiten von Diagnose bis Unterschrift

1. Adressat

bei Verlegung die übernehmende Abteilung **und** Überweiser **und** maßgeblich involvierte Ärzte (z.B. Gefäßchirurgen nach TEA)

2. Diagnosen (**ohne Abkürzungen, obwohl der vorliegende SOP solche enthält!**) mit:

- **Akuität** (z.B. akut, subakut, stattgehabt), am besten mit Datumsangabe
- **Was** (z.B. V.a. TIA, TIA (ohne Infarktnachweis), TIA mit Infarktnachweis, Infarkt, Blutung, … darüber hinaus den Begriff „Ischämie" vermeiden)
- **Größe** (z.B. totaler/subtotaler Mediainfarkt, hinterer/vorderer Mediateilinfarkt, kortikaler Mediateilinfarkt (ca. 3cm, ca. 5cm, ca. 10cm), supralentikulärer Infarkt (ca. 1,5cm))
- **Wo** (Stromgebiet, anatomische Region, z.B. totaler Media-Infarkt), Infarkt im Bereich der/des Medulla oblongata/Brücke/Mittelhirn/Thalamus, (supra)lentikulären Marklagers, Inselrinde)
- **Symptomatik**, **NIHSS bei Aufnahme und bei Entlassung**
- Systemische/intraarterielle Thrombolyse (rTPA-Dosierung)
- Ursache bei Ischämie nach den TOAST-Kriterien, siehe Extrablatt
  bei Blutung z.B. „Genese: a.e. hypertensiv"
- Relevante invasive Prozeduren wie z.B.: Tracheotomie nach Frova am … oder
  zerebrale Digitiale Subtraktionsangiografie am …
- kardiovaskuläre Risikofaktoren (gewichtet!)
- Ausnahme: Karotisstenose (incl. Lokalisation und distaler Stenosegrad mit Vmax) und Hochrisikokonstellationen für kardioembolische Ereignisse wie VHF extra aufführen
- **Komorbiditäten** (nach Priorität) z.B. 3-Gefäß-KHK mit drug eluting stent in der…seit dem...
- Vorerkrankungen: nur relevante, z.B. sollte die Appendektomie 1960 nur in die Anamnese

3. Epikrise mit:

- Umständen der Aufnahme (ggf. Datum, Uhrzeit des Symptombeginns)
- Diagnosesicherung (CT mit erkennbarem oder vermutetem Infarkt? MR?)
- Akute Therapie (Lyse bzw. mech. Rekanalisation ja/nein inklusive Begründung)
- Diagnostik (besonders DSA ja/nein bei Blutungen inklusive Begründung)
- Verlauf (nur Relevantes wie Antibiotika, Komplikationen, Tracheostomie …)
- Reha ja/nein – warum?
- Ggf. Sozialmedizinisches (z.B. Betreuung eingerichtet / einzurichten?)
- Ggf. Begründung der Sekundärprophylaxe:
  ASS+Dipyridamol, Clopidogrel immer [pAVK, **Essen-Risiko-Score, siehe auch SOP-Ordner]
  Statin z.B. so begründen: „trotz normaler Cholesterinserumwerte verordneten wir unter der Annahme einer Plaque-stabilisierenden Wirkung Simvastatin")
- Ggf. Zusatzdiagnostik
- Defizite bei Entlassung (immer auch in Worten im letzten Teil der Epikrise!)
- Auf die **Fahrtauglichkeit** soll **nicht mehr** obligat eingegangen werden, da es hierzu von den Fachgesellschaften keine Empfehlungen gibt

4. Procedere: unbedingt diese Sparte nutzen! Nicht vergessen, zeitlich begrenzte Therapie-empfehlungen anzugeben! (z.B. doppelte Plättchenhemmung nach Stent-PTA der ACI)

5. Medikation: Generika angeben, Med. weiter empfohlen? Nexium, MonoEmbolex … , neue Medikamente markieren

6. Anamnese: Schlüssig? Soziales? Aufnahmeindikation? Vollständige Vormedikation?

7. Klinischer Untersuchungsbefund: Schlüssig? Vollständig, inklusive internistischer Status mit RR und Puls.

8. Zusatzuntersuchungen: vollständig? z.B. EKG, LZ-Untersuchungen, EEGs ausgewertet?

9. SAP: DRG Diagnosen verschlüsselt? QS-Bogen (im SAP grünes Feld „OK")?

-> Arztbrief an Herrn Gösele weitergeben -> OA -> Prof. Hemmer

Toast-Kriterien

M. Mühlau, H. Poppert

zuletzt aktualisiert: 28.11.2008

Kateg.	Hinweise	Ausschluss	Formulierungshilfen Arztbrief
Kardio-emb.	**Wahrscheinlich:** VHF, künstl. Herzklappe, intrakardialer Thrombus laut TTE/TEE, MI < 4Wochen, dilatative KMP, VH-Myxom, bakt. Endokarditis, Kammerwandakinesie **Möglich:** Herzvitium, biolog. Herzklappe, nichtbakterielle Endokarditis, hypertroph. KMP, MI>4Wochen, Kammerwandhypokinesien	Makro-angiopathie mit Ischämien ausschließlich im entsprech. Stromgebiet (-> Ätiologie nicht zuordbar bei konkurr. Ursachen)	**Diagnosen:** „ …infarkt wahrscheinlich/ möglicherweise kardioembolisch bedingt“ {neue Zeile} Permanentes/persistierendes /paroxysmales Vorhofflimmern“ **Epikrise:** „bei permanentem Vorhofflimmern gehen wir von einer kardioembolischen Genese des Hirninfarktes aus“ Unterscheide: erstmals entdecktes VHF, paroxysmales VHF (≤7 Tage bis zum spontanen Sistieren), persistierendes VHF (>7 Tage bis zum spontanen Sistieren oder durch Therapie terminiert), permanentes VHF (>7 Tage / nicht terminierbar)
arterio-arteriell emb.	≥ 50% Stenose des entsprechenden Gefäßes Infarktgröße >1,5cm	Stenose < 50% VHF	**Diagnosen**: „…infarkt wahrscheinlich durch eine arterioarterielle Embolie bedingt bei {neue Zeile} Symptomatische Stenose im Bifurkationsbereich der linken Arteria carotis interna (lokaler Stenosegrad 70%, Vmax 200cm/s)“**Epikrise**: „Aufgrund der 70%igen Stenose der linken Arteria … gehen wir von einer arterio-arteriellen Embolie als Urs. des Hirninfarktes aus
lakunärer Infarkt	Klassisches lakunäres Syndrom? Infarkt <= 1,5cm	-„cortical dysfunction“ (Aphasie, Apraxie …) -Infarkt > 1,5 cm -kortikaler Infarkt	